

CAPÍTULO 9.15

Púrpura de Schonlein-Henoch

PERFIL EUNACOM 1.07.2.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

Epidemiología

- Más frecuente en **niños y adolescentes**; infrecuente en adultos
- Causa: depósito de **complejos inmunes IgA** en pequeños vasos

Tétrada Clínica

- Púrpura palpable** (no trombocitopénica) — miembros inferiores y glúteos predominan
- Artralgia o artritis**
- Dolor abdominal** (± hemorragia digestiva: hematoquecia)
- Nefritis por IgA** (hematuria dismórfica ± proteinuria) — determina el pronóstico

Diagnóstico

- Hemograma: normal** (plaquetas normales → es una púrpura no trombocitopénica)
- Examen de orina: hematuria ± proteinuria
- Si hay duda diagnóstica: biopsia de piel → depósito IgA

EUNACOM CRITERIOS

El compromiso renal es el indicador de pronóstico más importante en la PHS.

Tratamiento

TABLA 9.15.1: SITUACIÓN VS CONDUCTA	
SITUACIÓN	CONDUCTA
Solo púrpura + síntomas leves	Observar (autolimitada)
Dolor articular	AINEs
Artritis que no cede a AINEs	Corticoides
Dolor abdominal severo	Corticoides

| Afectación renal grave (IRA, proteinuria nefrótica) | **Corticoides** |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 6 años presenta cuadro de 4 días de dolor abdominal cólico intermitente, dolor e inflamación en ambos tobillos y rodillas, y aparición de lesiones maculopapulares eritematosas palpables simétricas en glúteos y cara posterior de piernas, 2 semanas después de una faringitis aguda. Sedimento de orina: hematuria microscópica y proteinuria leve. Hemograma con plaquetas normales (280.000/mm³)."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Vasculitis por IgA (Púrpura de Schönlein-Henoch): vasculitis leucocitoclástica por depósito de inmunocomplejos IgA más frecuente en pediatría. Tétrada clásica: Púrpura palpable de predominio en EEL y glúteos + Artralgias/artritis no erosiva + Dolor abdominal (por isquemia submucosa, riesgo de invaginación intestinal) + Nefritis por IgA. Las plaquetas son estrictamente normales. Manejo: reposo, analgesia con AINEs/Paracetamol y seguimiento de función renal y PA por 6 meses.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Púrpura de Schonlein-Henoch = Vasculitis por IgA, se ve principalmente en niños
- Tétrada: púrpura palpable + afectación renal + articular + gastrointestinal
- Hemograma absolutamente normal (púrpura NO trombocitopénica)
- El diagnóstico es clínico; si hay duda, biopsia de piel muestra depósito de IgA
- El compromiso renal determina el pronóstico
- Tratamiento general: observación + AINEs para dolor leve
- Corticoides solo si: artritis refractaria a AINEs, dolor abdominal severo, o afectación renal grave

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PÚRPURA DE SCHONLEIN-HENOC)

PREGUNTA 1

Niño de 7 años con púrpura palpable en extremidades inferiores, dolor abdominal, artralgia de rodillas y hematuria. Hemograma con plaquetas normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** PTI aguda
- B)** PTT
- C)** Púrpura de Schonlein-Henoch
- D)** Meningococcemia
- E)** CID

PREGUNTA 2

En la púrpura de Schonlein-Henoch, ¿cuál es la afectación que determina el pronóstico?

- A)** La púrpura cutánea
- B)** La afectación articular
- C)** La afectación gastrointestinal
- D)** La afectación renal
- E)** La afectación hepática

PREGUNTA 3

Niño con púrpura de Schonlein-Henoch que presenta dolor abdominal severo que no mejora con AINEs. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Continuar observación
- B)** Iniciar corticoides orales
- C)** Realizar colonoscopia de urgencia
- D)** Iniciar antibióticos
- E)** Transfundir plaquetas

RESUMEN: PÚRPURA DE SCHONLEIN-HENOC

Esta clase cubre la púrpura de Schonlein-Henoch, también llamada vasculitis por IgA. Se ve principalmente en niños y adolescentes, siendo muy rara en adultos. Se caracteriza por una tétrada: púrpura palpable en extremidades inferiores/glúteos, afectación renal (glomerulonefritis por IgA), afectación articular (artralgia/artritis) y afectación gastrointestinal (dolor abdominal, vómitos, hematoquecia). El hemograma es absolutamente normal (púrpura no trombocitopénica). El diagnóstico es clínico. El compromiso renal determina el pronóstico. Si hay duda, se puede biopsiar piel (depósito de IgA). El tratamiento es observación con AINEs para dolor leve. Los corticoides orales se indican en: artritis que no responde a AINEs, dolor abdominal severo, y afectación renal grave (glomerulonefritis rápidamente progresiva, insuficiencia renal aguda, proteinuria en rango nefrótico o >1 g).